

Síntomas guía: otalgia, hipoacusia, rinorrea, epistaxis, disfagia, disfonía

1. Introducción y relevancia clínica

Los **síntomas guía otorrinolaringológicos** son manifestaciones clínicas frecuentes en la atención médica primaria. Representan signos de disfunción en estructuras del oído, nariz, senos paranasales, faringe o laringe.

Su correcta interpretación permite diferenciar entre patologías leves y procesos graves que requieren derivación urgente.

El médico general debe ser capaz de **asociar el síntoma con su origen anatómico y fisiopatológico**, realizar una evaluación básica y definir el manejo inicial o la derivación oportuna al especialista ORL.

Los seis síntomas cardinales —**otalgia, hipoacusia, rinorrea, epistaxis, disfagia y disfonía**— constituyen la base de la **semiología ORL** y son recurrentes en preguntas del **EUNACOM**, especialmente en la sección clínica.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Cada síntoma refleja un **mecanismo fisiopatológico específico** que puede involucrar inflamación, obstrucción, disfunción nerviosa o procesos neoplásicos. Comprender su origen anatómico es clave para un razonamiento clínico estructurado.

2.1 Otalgia (dolor de oído)

Definición:

Dolor percibido en la región auricular o adyacente. Puede ser **primaria (originada en el oído)** o **secundaria (referida)**.

Fisiopatología:

La rica inervación sensitiva del oído (nervios V, VII, IX, X y plexo cervical) permite irradiación del dolor desde estructuras vecinas (ATM, dientes, faringe).

2.2 Hipoacusia

Definición:

Disminución de la capacidad auditiva parcial o total, unilateral o bilateral.

Clasificación fisiopatológica:

1. **De conducción:** compromiso del oído externo o medio (impide transmisión del sonido).
2. **Neurosensorial:** daño en cóclea o nervio auditivo.
3. **Mixta:** afectación combinada.

El tipo de hipoacusia orienta la etiología y el tratamiento.

2.3 Rinorrea

Definición:

Salida de secreción nasal (acuosa, mucosa o purulenta).

Fisiopatología:

El epitelio nasal y de los senos paranasales contiene glándulas y células caliciformes que secretan moco para humidificar y proteger. La inflamación (infecciosa o alérgica) altera este equilibrio, produciendo hipersecreción o bloqueo del drenaje.

2.4 Epistaxis

Definición:

Hemorragia proveniente de las fosas nasales.

Origen: 90% anterior (plexo de Kiesselbach), 10% posterior (ramas de la arteria esfenopalatina).

Fisiopatología:

La mucosa nasal es altamente vascularizada y susceptible a ruptura por traumatismos, inflamación, hipertensión o trastornos de coagulación.

2.5 Disfagia

Definición:

Dificultad o dolor al tragar.

Puede ser **orofaríngea** (inicio deglutorio) o **esofágica** (paso del bolo).

Fisiopatología:

La coordinación neuromuscular entre orofaringe, epiglotis y esfínteres es esencial. Su alteración puede deberse a infecciones, neoplasias o enfermedades neurológicas (ACV, Parkinson).

2.6 Disfonía

Definición:

Alteración del tono, timbre o intensidad de la voz.

Fisiopatología:

Resulta de inflamación, lesión o parálisis de las cuerdas vocales, o de la alteración en la vibración laríngea.

Clasificación:

- **Aguda:** habitualmente infecciosa o por abuso vocal.
 - **Crónica:** causas funcionales, estructurales o tumorales.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

A continuación, se analizan los **principales síntomas guía** con su **presentación clínica típica** y diagnóstico diferencial orientativo.

3.1 Otolgia

Causas primarias (otológicas)

Etiología

Características

Hallazgo otoscópico

Otitis externa aguda	Dolor al traccionar pabellón, prurito, supuración	Conducto eritematoso y edematoso
Otitis media aguda	Dolor pulsátil, fiebre, hipoacusia	Tímpano abombado, hiperémico
Tapón de cerumen	Sensación de oído tapado	Cerumen obstructivo
Barotrauma	Dolor tras cambios de presión	Retracción o hemorragia timpánica

Causas secundarias (referidas)

Fuente	Mecanismo	Claves clínicas
Faringe / amígdalas	N. glosofaríngeo	Dolor de garganta irradiado a oído
Articulación temporomandibular	N. auriculotemporal	Dolor al masticar
Dientes o encías	N. trigémino	Dolor dental irradiado
Cáncer orofaríngeo	N. vago / glosofaríngeo	Dolor persistente, unilateridad, masa cervical

Diagnóstico diferencial clave:

En otalgia con otoscopía normal → **buscar causa secundaria.**

Toda otalgia persistente unilateral en adulto fumador requiere descartar **neoplasia de orofaringe o laringe.**

3.2 Hipoacusia

A) De conducción

Causa	Clínica típica	Exploración
Tapón de cerumen	Inicio súbito, sin otalgia	Otoscopía con cerumen
Otitis media serosa	Hipoacusia leve, sensación de oído tapado	Nivel hidroaéreo
Otitis media crónica	Supuración y hipoacusia progresiva	Perforación timpánica
Disfunción tubárica	Cambios de presión, vuelos	Retracción timpánica

B) Neurosensorial

Causa	Clínica	Exploración
Presbiacusia	Progresiva, bilateral	Audiometría descendente
Exposición a ruido	Unilateral o bilateral	Antecedente laboral
Neuritis vestibular	Súbita, con vértigo	Weber lateralizado al oído sano
Tumor del acústico	Pérdida unilateral progresiva	Confirmar con RMN

C) Pruebas semiológicas

- **Rinne (+):** conducción aérea > ósea → normal o neurosensorial.

- **Weber:** lateraliza al oído afectado en hipoacusia conductiva.
-

3.3 Rinorrea

Tipo de secreción	Etiología probable	Características asociadas
Acuosa y bilateral	Rinitis alérgica o viral	Prurito, estornudos, congestión
Purulenta y unilateral	Sinusitis bacteriana o cuerpo extraño	Dolor facial, halitosis
Mucosa crónica	Poliposis o desviación septal	Obstrucción nasal progresiva
Clara posraumática	Fístula de LCR	Rinorrea posicional, antecedente trauma craneal

Claves:

- Rinorrea unilateral purulenta en niño → **cuerpo extraño nasal**.
 - Rinorrea acuosa persistente tras trauma → sospechar **fístula de LCR**.
-

3.4 Epistaxis

Epistaxis anterior (90%)

- Origen: **plexo de Kiesselbach (área de Little)**.
- Leve, autolimitada.
- Frecuente en niños y adultos jóvenes.
- Asociada a rinitis, traumatismo digital o sequedad ambiental.

Epistaxis posterior (10%)

- Origen: arteria esfenopalatina.
- Más severa, común en ancianos hipertensos.
- Puede comprometer vía aérea.

Diagnóstico diferencial:

- Trastornos hematológicos, anticoagulantes, tumores nasales, drogas intranasales (cocaína).

Manejo inicial:

- Compresión digital (10 min).
- Vasoconstrictor tópico (oximetazolina).
- Taponamiento anterior si persiste.
- Derivar si sospecha de epistaxis posterior o refractaria.

3.5 Disfagia

Clasificación:

Tipo	Localización	Ejemplo de causa
Orofaringea	Falla en inicio de deglución	ACV, faringitis, absceso
Esofágica	Sensación de alimento detenido	Estenosis, cáncer esofágico

Causas frecuentes en ORL:

- Faringoamigdalitis aguda.
- Absceso periamigdalino o retrofaríngeo.

- Cáncer orofaríngeo o laríngeo.
- Parálisis bulbar.

Claves clínicas:

- Dolor al tragar (odinofagia): proceso inflamatorio.
- Dificultad progresiva sin dolor: causa obstructiva o neoplásica.
- Regurgitación nasal o tos al tragar: disfunción neurológica.

3.6 Disfonía

Duración	Causa probable	Ejemplo
Aguda (<3 sem)	Laringitis viral, abuso vocal	Docentes, cantantes
Crónica (>3 sem)	Nódulos, pólipos, reflujo, tumor laríngeo	Fumadores, GERD

Signos de alarma:

- Disfonía persistente >3 semanas.
 - Dolor, odinofagia, hemoptisis o masa cervical asociada.
- Requieren derivación urgente a ORL (descartar cáncer de laringe).

Exploración:

- Evaluar voz (ronquera, astenia vocal).
- Laringoscopia: movilidad, lesiones o masas.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Síntoma	Exámenes recomendados	Propósito
Otalgia	Otoscopía, TAC si mastoiditis	Diferenciar otitis o causa refleja
Hipoacusia	Audiometría, timpanometría	Tipo de pérdida auditiva
Rinorrea	Cultivo, TAC senos	Confirmar sinusitis bacteriana
Epistaxis	Hemograma, TTPK, endoscopia nasal	Evaluar coagulopatía o lesión estructural
Disfagia	Nasofibroscopía, videodeglución	Evaluar motilidad y masa obstructiva
Disfonía	Fibrolaringoscopia	Valorar cuerdas vocales y descartar neoplasia

Criterios de derivación inmediata a ORL:

- Otalgia con mastoiditis o parálisis facial.
- Hipoacusia súbita unilateral.
- Epistaxis posterior o masiva.
- Disfagia progresiva o con aspiración.
- Disfonía persistente >3 semanas.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

Síntoma	Manejo inicial	Derivación
---------	----------------	------------

Otalgia	Analgésicos, antibióticos si otitis media (amoxicilina 80 mg/kg/día)	Si supuración persistente o mastoiditis
Hipoacusia	Retirar cerumen, tratar infección	Si hipoacusia neurosensorial súbita
Rinorrea	Irrigación salina, antihistamínicos o antibióticos según etiología	Si crónica o con poliposis
Epistaxis	Compresión, vasoconstrictor, taponamiento	Si posterior o recurrente
Disfagia	Analgésicos, hidratación, antibióticos si infección	Si progresiva o con disnea
Disfonía	Reposo vocal, hidratación, tratar reflujo	Si persiste >3 semanas

6. Complicaciones y pronóstico

Síntoma	Complicaciones posibles	Pronóstico
Otalgia	Mastoiditis, hipoacusia permanente	Excelente si manejo precoz
Hipoacusia	Aislamiento social, retraso en lenguaje (niños)	Variable según tipo
Rinorrea	Sinusitis crónica, poliposis	Bueno con tratamiento
Epistaxis	Anemia, shock hipovolémico	Favorable si control local

Disfagia	Aspiración, neumonía	Reservado si neurológica
----------	----------------------	--------------------------

Disfonía	Cáncer laríngeo, obstrucción aérea	Bueno si diagnóstico precoz
----------	------------------------------------	-----------------------------

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. Otolgia sin hallazgos → buscar fuente refleja (ATM, faringe, dientes).
2. Hipoacusia súbita unilateral = **emergencia médica** (derivar en <24 h).
3. Rinorrea unilateral fétida en niño = cuerpo extraño nasal.
4. Epistaxis posterior se sospecha si sangre fluye hacia orofaringe.
5. Disfagia con voz apagada o estridor → pensar en **absceso retrofaríngeo o epiglottitis**.
6. Toda disfonía >3 semanas debe derivarse para descartar cáncer de laringe.

Errores comunes

- Usar antibióticos en rinorrea viral.
- No revisar el oído contralateral en otalgia.
- No derivar epistaxis posterior.
- Tratar disfonía crónica como “laringitis” sin exploración laríngea.
- Ignorar disfagia progresiva en ancianos.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Los síntomas guía ORL reflejan alteraciones anatómicas precisas que orientan el diagnóstico clínico.
2. La **otalgia** puede ser primaria (otitis) o referida (faringe, ATM, dientes).
3. La **hipoacusia** se clasifica en conductiva, neurosensorial o mixta; la súbita es una urgencia.
4. La **rinorrea** y **epistaxis** orientan a patologías nasales frecuentes, pero pueden ocultar causas graves.
5. La **disfagia** inflamatoria es dolorosa, mientras que la progresiva sugiere tumor o estenosis.
6. Toda **disfonía persistente >3 semanas** requiere estudio laríngeo (descartar cáncer).
7. La correlación entre **síntoma + examen físico dirigido + diagnóstico diferencial** es clave para el éxito en EUNACOM y la práctica clínica.